

Tumores do Colo Uterino

#gineco

#câncer

#útero

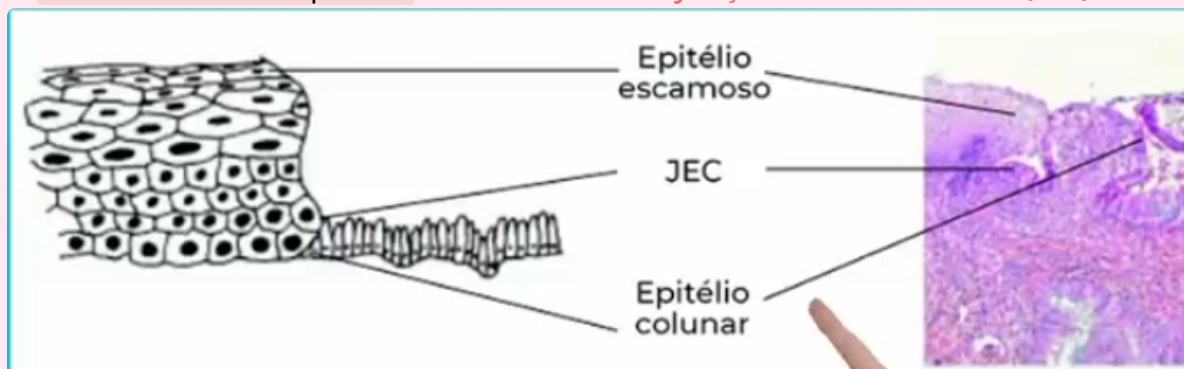
#rastreio

#hpv

- Quarto câncer mais frequente em mulheres;
- No Brasil é o **segundo câncer ginecológico mais frequente**, só perdendo para o câncer de mama;
- Sua **incidência é maior entre 35-50 anos** especialmente em países sem programa de rastreamento;
- O tipo histológico mais comum é o **carcinoma de células escamosas** ou carcinoma epidermoide, seguido pelo **adenocarcinoma**;
- O principal **fator de risco** é a infecção pelo Papiloma vírus humano (HPV);
 - 70-90% dos pacientes com HPV regridem espontaneamente;
 - No entanto apenas o HPV em si não é capaz de causar uma lesão precursora ou câncer;
 - NECESSÁRIO **persistência viral**.
 - e/ou associação com **outros fatores de risco**.
 - tabagismo;
 - imunossupressão;

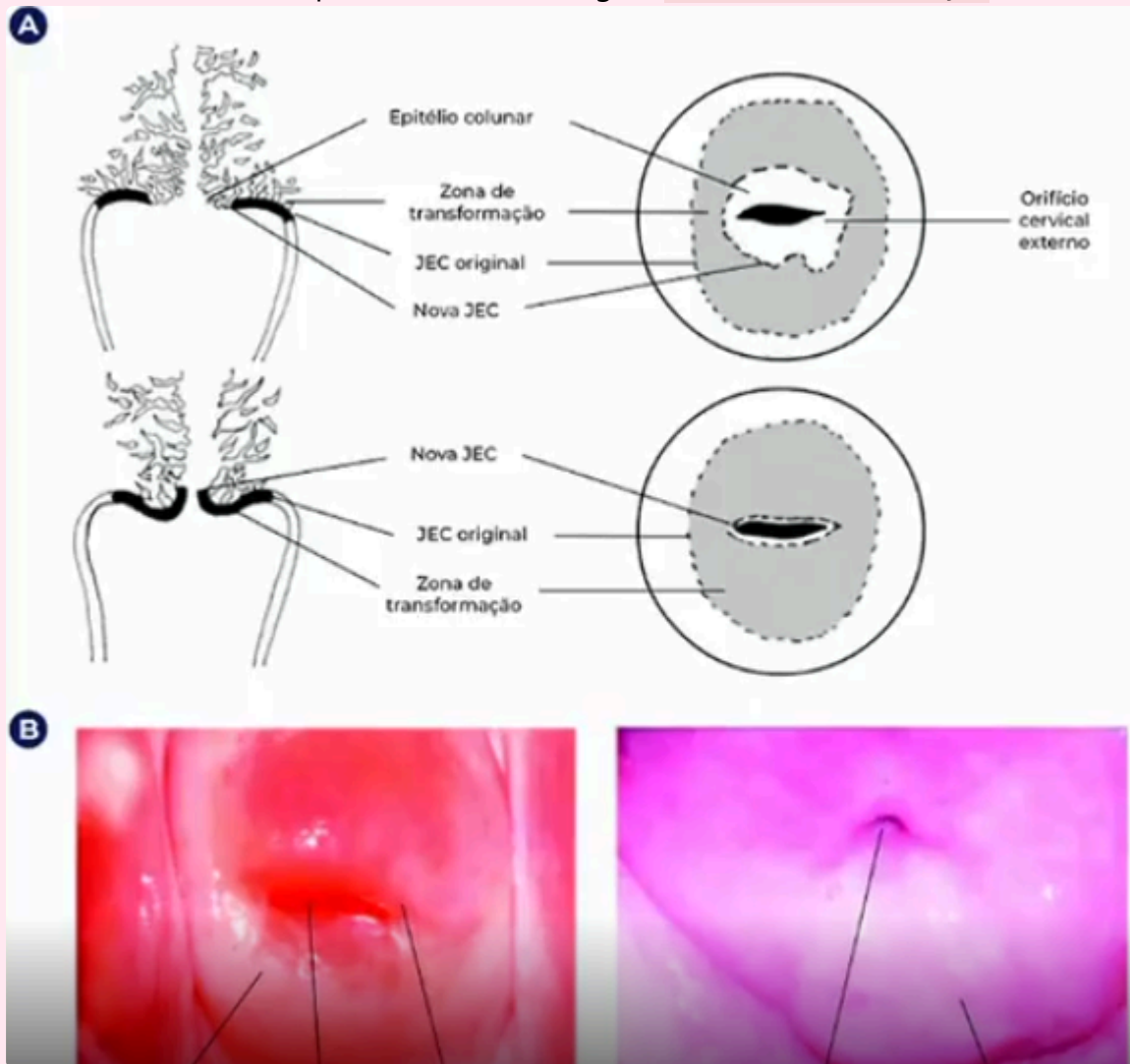
Anatomia e histologia

- O colo uterino possui formato cilíndrico;
- É dividido em endocérvice e ectocérvice;
 - **Ectocérvice**: epitélio escamoso estratificado não queratinizado;
 - **Endocérvice**: epitélio cilíndrico simples glandular (produz muco cervical);
 - A **união desses dois epitélios** é denominada de **junção escamo-colunar (JEC)**;



- Nos casos de eversão/ectopia, o epitélio glandular sofre metaplasia escamosa;
- Muito comum principalmente em pacientes jovens e em uso de ACO combinado;

- Resultante dessa metaplasia escamosa, surge a Zona de Transformação;



→Cisto de Naboth: obstrução glandular na zona de transformação;

- Fisiológico e benigno;



Infecção pelo HPV

- Mais de 200 tipos identificados;
 - Baixo risco oncogênico: 6 e 11 (principais);

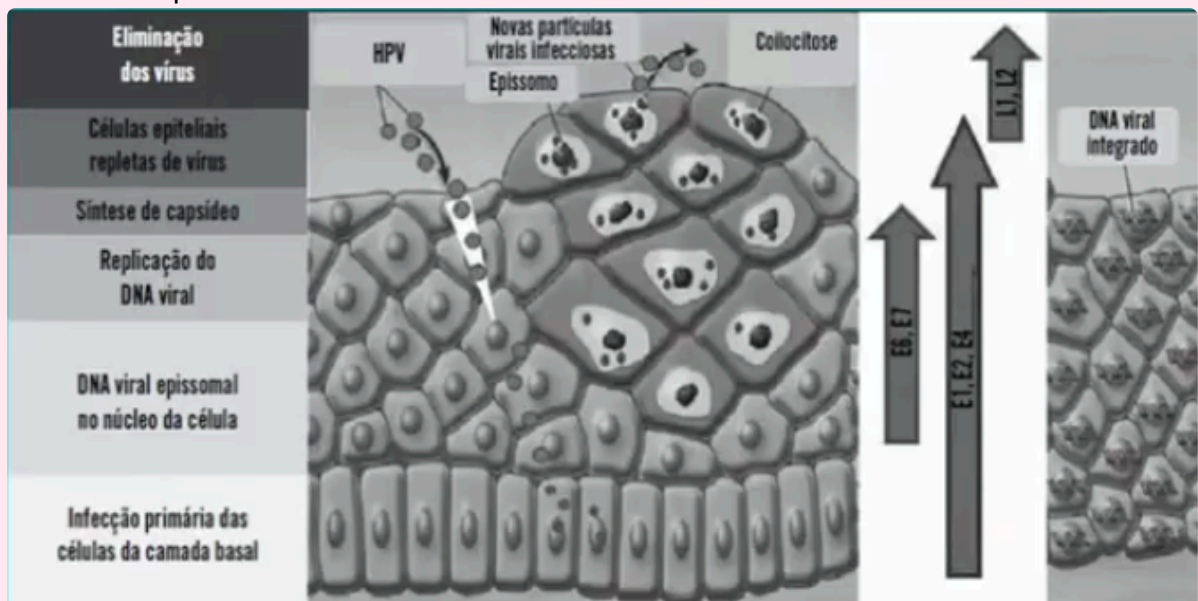
- Causadores de condiloma acuminado sem potencial oncogênico;



- Alto risco oncogênico: 16 e 18 (principais);
- A transmissão ocorre através do contato, não apenas através da relação sexual;
- A infecção pode ter diferentes cursos:
 - Regressão espontânea (80%);
 - Persistência viral subclínica;
 - Lesões clinicamente ativas;

Vírus

- Formado por:
 - Cápsula;
 - DNA em dupla fita;



Características histológicas do HPV

- Núcleos aumentados e hipercrômicos → aumenta da relação núcleo/citoplasma;
- Hiperchromasia: excesso de cromatina;
- **Coilocitose** (uma das principais alterações): formação de vacúolos que deslocam o núcleo para a periferia da célula;
- Distribuição irregular da cromatina;
- Figuras de mitose e nucléolos visíveis;

Tratamento condiloma acuminado

- Pode ser químico, imunológico, cauterização e também ressecção cirúrgica;
 - Podofilina: baixa eficácia e efeitos adversos: contraindicada na gestação;
 - Hepatotóxica e neurotóxica;
 - Ácido tricloroacético (ATA): seguro para gestantes, aplicado ambulatorialmente;
 - Não pode ser aplicado em regiões muito grandes;
 - 5-fluoracil: efeito antimetabólico
 - Imiquimode- imunomodulador (INF-alfa);
 - Eletrocauterização/Criocauterização;
 - Laser;
 - Ressecção cirúrgica;

Prevenção

- Vacina para HPV;
- No Brasil, a vacina fornecida pelo SUS é quadrivalente (HPV 6-11-16-18);
- Partículas semelhantes ao vírus (VLP);
 - Contém o capsídeo viral sem o RNA infectante d vírus;
 - Gestantes podem tomar;
- Esquema fornecido pelo MS:
 - Vacina quadrivalente em 2 doses: 0 e 6;
 - Meninas e meninos de 9-14 anos;
 - HIV (+) ou imunossupressão:
 - Homens e mulheres 9-45 anos (3 doses: 0-2-6);
- Pode ser aplicado mesmo em quem já teve contato com o HPV;

⚠ Atenção!!

Preferível iniciar antes da atividade sexual, mas isso não deve ser um impeditivo (se não tomou, pode tomar depois);

No SUS, desde que na idade alvo; Se fora dela, apenas na rede privada

Câncer de Colo de útero

- Principal fator de risco: HPV de alto risco oncogênico (principalmente 16 e 18);
- Prevenção primária: Vacinação;

[a] Rastreio

Citologia oncológica'

- Iniciar aos 25 anos;
- A cada 1 ano; Se 2 exames negativos, pode-se espaçar intervalo para 3 anos;

- Interromper aos 64 anos após 2 exames negativos;

→ Situações especiais de rastreamento:

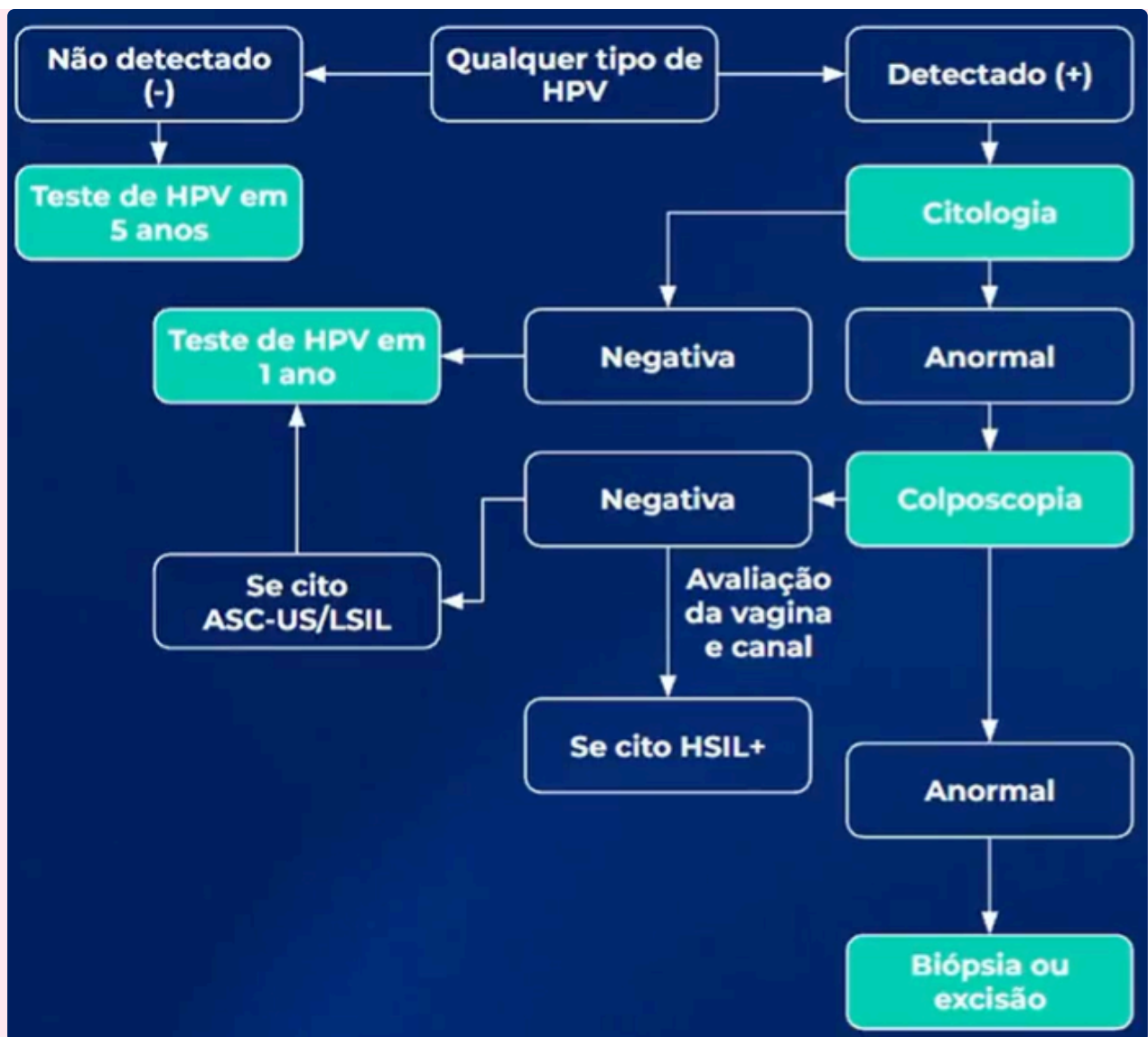
- Gestantes: rastreio usual;
- HIV (+): iniciar após sexarca (independentemente da idade) a cada 6 meses no 1º ano e depois, anualmente;
 - Se CD4 <200 manter de 6/6 meses;
- Virgens: não colher;
- Pós-menopausa com atrofia genital: estrogenização tópica pro 21 dias, com coleta 5-7 dias após a parada do uso;
- Parar de colher após histerectomia total por DOENÇA benigna, sem história de lesão de alto grau;
- Histerectomia subtotal (preserva colo) continua colhendo CCO normalmente

Cuidados previamente á coleta:

- Não realizar ducha vaginal 48h antes;
- Não ter atividade sexual nas 72 horas prévias;
- Não usar creme vaginal nos 7 dias prévios;
- Evitar uso de gel ou lubrificante no espécuro;
- Como colher:
 - Ectocérvice: espátula de ayre;
 - Endocérvice: cytobrush;

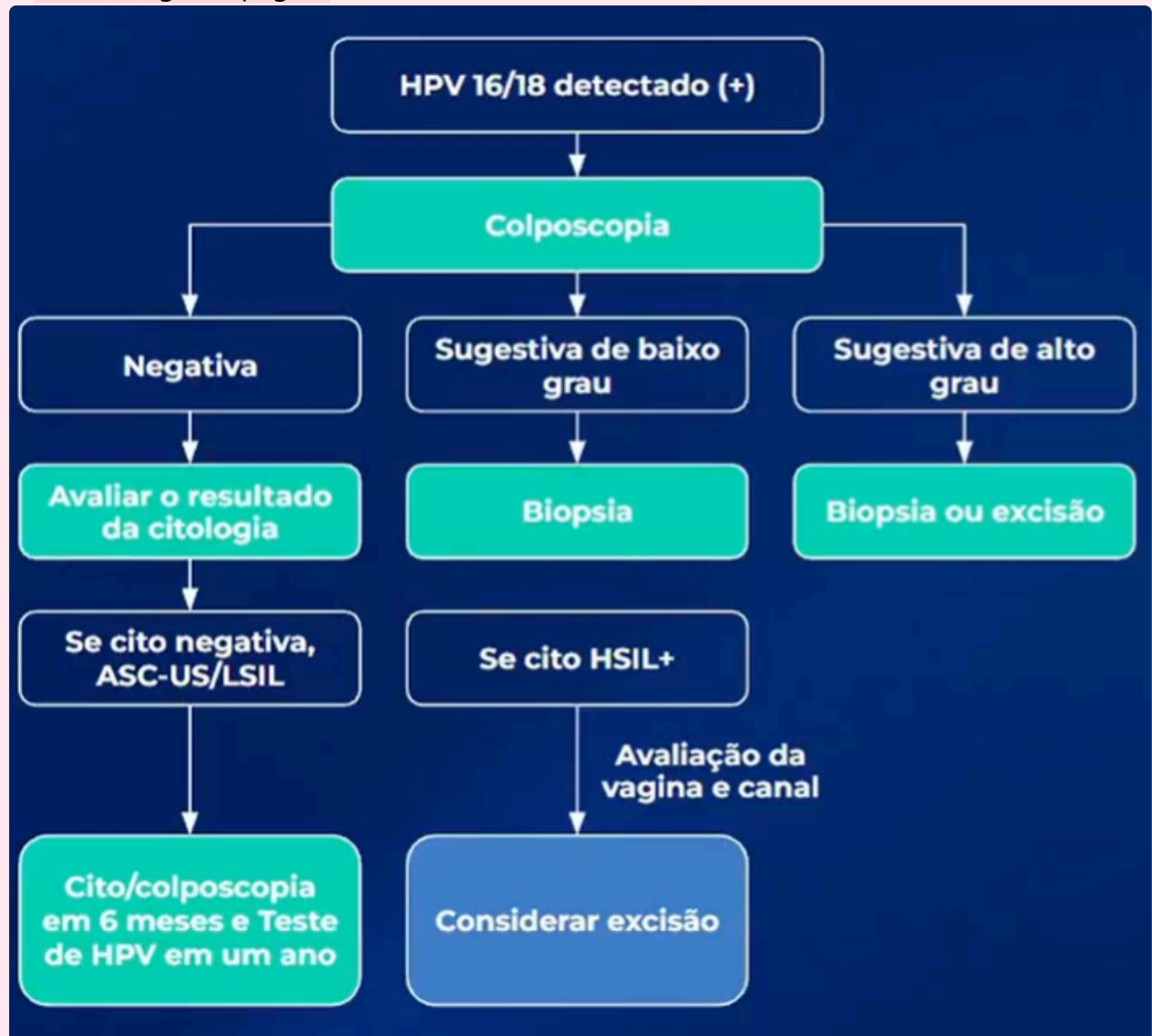
Rastreamento pelo DNA-HPV

- Recomendações da febrasgo, OMS, USPTF, ACOG → MS mantém recomendação com CO;
- Mulheres > 30 anos;
 - O teste de HPV isolado pode substituir a CO.
 - Periodicidade a cada 5 anos;
 - Citologia: triagem em caso de teste HPV +
- Mulheres entre 25 e 29 anos:
 - Podem ser rastreadas com o teste HPV;
 - Recomendam associar a genotipagem para reduzir o risco de diagnóstico em excesso e o sobretratamento;
- Coteste (HPV + Citologia) não é recomendado;
- Rastreamento pode ser descontinuado aos 65 anos de idade se nos últimos 10 anos houve controle negativo e adequado;



- LSIL: Lesão de baixo grau;
- HSIL: Lesão de alto grau;

→Se tiver a genotipagem:



Nomenclatura das Alterações- CO

Atipia em células escamosas:

- Lesão intraepitelial de baixo grau (LIEBG);
- Lesão intraepitelial de alto grau (LIEAH);
- Carcinoma Epidermoide invasor;

Alterações em células glandulares

- Adenocarcinoma in situ (AIS);
- Adenocarcinoma invasor;

Células atípicas de resultado indeterminado

- Escamosas (ASC):
 - Possivelmente não neoplásicas (ASC-US);
 - Não podem excluir lesão intraepitelial de alto GRAU (ASC-H);

- Glandulares (AGC);

 Fica ligado!

- Em caso de AGC para pacientes ≥ 35 anos, fazer **ultrassom abdominal**.

De origem indefinida (AOI)

- Possivelmente não neoplásica;
- Não se pode afastar lesão intraepitelial de alto grau;

 Cuidado com a **nomenclatura**

- ASCUS, LSIL, HSIL: nomenclaturas usadas para alterações citológicas.
- NIC 1, 2 e 3: nomenclaturas histológicas;

Rastreamento Citológico

Diagnóstico citopatológico		Faixa etária	Conduta inicial
Células escamosas atípicas de significado indeterminado (ASCUS)	Possivelmente não neoplásicas (ASC-US)	< 25 anos	Repetir em 3 anos
		Entre 25 e 29 anos	Repetir citologia em 12 meses
		≥ 30 anos	Repetir citologia em 6 meses
	Não se podendo afastar lesão de alto grau (ASC-H)		Encaminhar para colposcopia
Células glandulares atípicas de significado indeterminado (AGC)	Possivelmente não neoplásicas ou não se podendo afastar lesão de alto grau		Encaminhar para colposcopia

Diagnóstico citopatológico		Faixa etária	Conduta inicial
Células atípicas de origem indefinida (AOI)	Possivelmente não neoplásicas ou não se podendo afastar lesão de alto grau		Encaminhar para colposcopia
Lesão de Baixo Grau (LSIL)		< 25 anos	Repetir em 3 anos
		≥ 25 anos	Repetir a citologia em 6 meses
Lesão de Alto Grau (HSIL)			Encaminhar para colposcopia
Lesão intraepitelial de alto grau não podendo excluir microinvasão			Encaminhar para colposcopia
Carcinoma escamoso invasor			Encaminhar para colposcopia
Adenocarcinoma in situ (AIS) ou invasor			Encaminhar para colposcopia

 Resumindo pra não aumentar a lotação nos manicômios:

Normal: seguimento habitual;

ASC-US:

- <25 anos: repetir em 3 anos; ou aos 25
- 25-29: repetir em um ano;
- ≥30 anos: repetir em 6 meses;

Indica colposcopia se 2 COs positivos com esse tipo de lesão.

LIEBG (LSIL):

- <25 anos: repete em 3 anos;
- ≥25 anos repete em 6 meses;

Indica colposcopia se 2 COs positivos com esse tipo de lesão.

ASC-H, AGC, LIEAG (HSIL), AIS, AOI, carcinoma escamoso e adenocarcinoma invasor:

Encaminhar para **colposcopia**;

Além disso pacientes imunossuprimidas, com qualquer tipo de alteração devem ser encaminhadas á colposcopia diante de qualquer alteração

Colposcopia



- **Ácido acético**: precipitação reversível das proteínas nucleares e citoqueratinas: acetobranqueamento;
- **Lugol**(Teste de Schiller): captação do iodo pelo epitélio que contém glicogênio;

Pulo do Gato

CUIDADO COM PEGADINHAS

O teste de Schiller é POSITIVO quando a área é iodo negativa (anormal) e o teste de Schiller é negativo quando a área é iodo positiva;

Achados colposcópicos menores

- Epitélio acetobranco tênue
 - Mosaico fino
 - Pontilhado fino



Achados colposcópicos MAIORES

- Epitélio acetobranco tênue;
- Mosaico grosseiro;

Achado suspeito de invasão:

- Vascularização atípica, necrose e tumoração;
- Realizar biópsia dirigida para obtenção de material histológico;

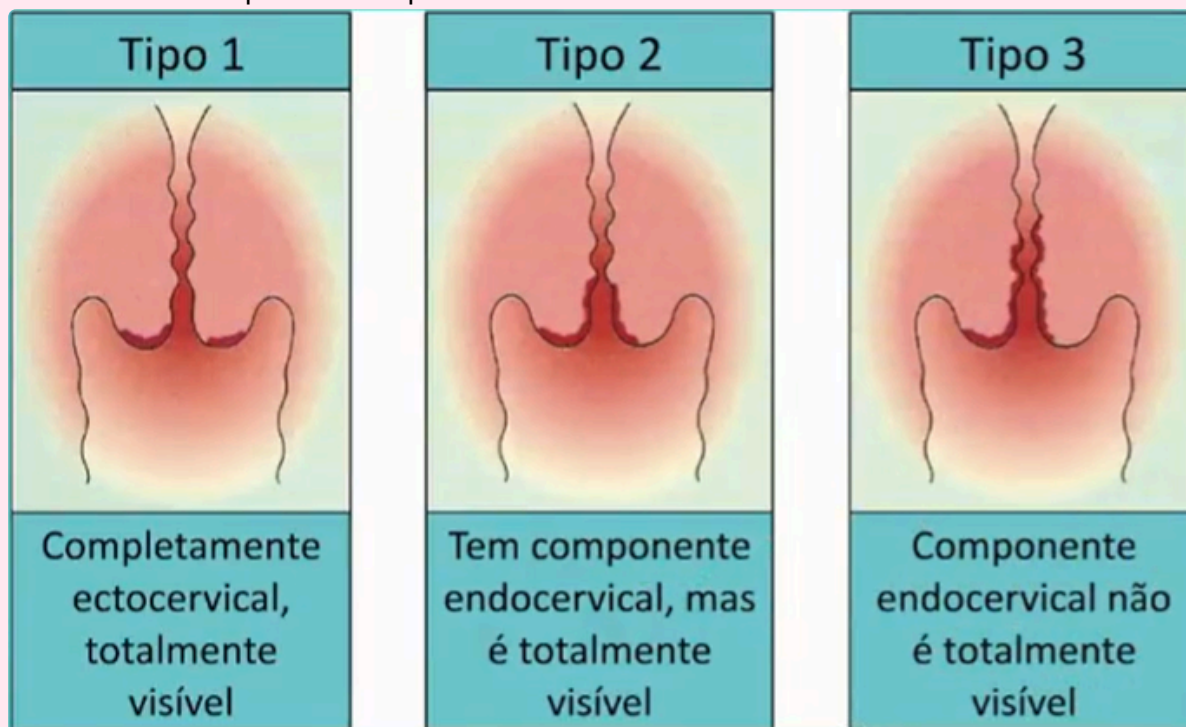
Displasia cervical

- Lesões percussoras;
- A neoplasia intraepitelial escamosa cervical é um termo que abrange as lesões percussoras do câncer escamoso;
- São classificadas em graus de 1, 2 e 3;
 - 1: só alterou membrana basal;
 - 2: 2/3 da camada alterada;
 - 3: toda a camada;

Tratamento

→ Nick 1: expectante; Com CO e colonoscopia semestral;

- Após 2 anos, pode considerar tratar com terapias destrutivas (laser, crioterapia, cauterização);
- Nick 2 e NIC 3: exérese da lesão; EZT (exérese de cone de transição) ou cone;
 - EZT ou cone? Depende do tipo de ZT:



- Tipo 1: até 1cm do canal- CAF (Cirurgia de Alta Frequência)*
- Tipo 2: 1,5 e 2,0 cm
- Tipo 3: 2 e 2,5 cm- CONE*

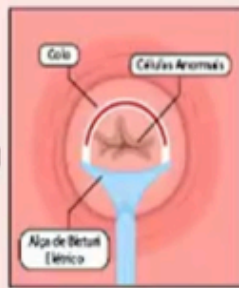
CAF (Cirurgia de alta frequência)



Cirurgia de alta frequência (CAF)



During procedure the electrocautery loop is inserted through vagina to cervix.



Retirada da área anormal do colo por bisturi elétrico



Conização à Frio



- Equivalente à EZT do tipo 3;
- HSIL em que: limites são definidos, JEC não visível na colonoscopia, suspeita de microinvasão;
- No caso de carcinoma in situ é um procedimento DX + terapêutico;

See and Treat

- EZT no momento da colposcopia;
- Critérios:
 - Achados anormais maiores;
 - Concordância entre a colposcopia e a citologia;
 - JEC visível;
 - Lesão restrita ao colo;

- Ausência de suspeita de invasão ou doença glandular.